

CD73210704723

H36906041E0D3

INDICADO POR: Dr. Gisel

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS J37161965964E

EMELIN NAGASSAKI SAITO

IDADE: 49 PESO: 66 ALTURA: 156 PROFISSÃO: Recepcionista

SINTOMAS: Sonolenta / cansaço / refluxo gástrico / esgueirado

QUEIXAS: falta de ar / ronco alto / acorda c/ ↑ FC e ofegante

MEDICAMENTOS: Pitarbust. (4mg)

MÉDICO: Dr. Guio / Dr. Gisel

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Cominbrado

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 18h

HORA QUE DORME: 21:30 HORA QUE ACORDA: 5:30

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: bucal / nasal BANHEIRO/NOITE: 2x3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 33,0 SPO2: 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

Inflamação do nervo plantar / tendão aquiril esquerdo.
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Prova e fe c/ leve distúrbio venti. obstr.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA Círculo fereol ↑

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS: -

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

07/02 Avaliação
2512/02/25 Pte veio relatando ter desconforto
aparelho, solicitou 1 Pínica p/ 4 noites
P= 4-9 cm H₂O

IAH: 5,7 e/h

mdc uso: 8 h 11'

Natacha

18/02/25 Pmud: 6,2 cm H₂O

IAH: 3,2 e/h

mdc uso: 6 h 03'

Relata acordar muito a
noite

Natacha

P= 6,2 cm H₂O

IAH= 5,4 e/h

M. de uso: 3h 50'

Bem adapt., mas está acordando pelo 4 do
pulso

Jus.

Nome: EMELIN NAGASSAKI SAITO
Data de Nascimento: 20-9-1975
IMC: 26,50
Sexo: Feminino
Data do exame: 18-10-2024

Peso: 67 kg
Altura: 1,59 m
Médico: DR. ENIO NARUHIRO KOKUBU
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 18-10-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 515,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 29,0 e 80,0 minutos. O tempo total de sono foi de 408,5 min, eficiência de 79,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 55,9%; estágio N3: 19,2%; sono REM: 22,3%. O índice de despertares foi de 15,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 33,0/hora, sendo 71 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 101 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 83%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 92 bpm e NREM de 54 - 96 bpm.

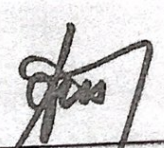
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 33,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=83%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157